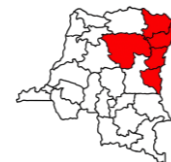




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°101/MVEBDB/24/08/2026

Date de rapportage : 24 août 2026

Date de publication : 25 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

En date du 24 août 2026, 72 nouveaux cas confirmés dont 18 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (61 cas), du Nord-Kivu (7 cas), Haut Uélé (3) et au Bas-Uélé (1). Une nouvelle zone de santé (Ganga) au Bas-Uélé a été touchée au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS 5 656	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 715	LETALITE 48,0%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 792	CUMUL DES GUÉRIS 1 245	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 80,9 %
--	--	-------------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



58 Zones de santé touchées sur 151

(38,4%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, **72 nouveaux cas confirmés** dont **18 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'**Ituri (61 cas)**, **Nord-Kivu (7)**, **Haut Uélé (3)** et **Bas Uele (1)**.

Au cours de dernières 24 heures, **30 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (23 en Ituri, 4 au Nord Kivu et 3 au Haut Uélé). D'autre part, **17 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 16 en Ituri et 1 au Haut Uélé.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 24 août 2026, **5 656 cas confirmés** dont **2 715 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,0 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 83,4 % des cas confirmés cumulés et 84,7 % des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures.

Une nouvelle zone de santé (Ganga, au Bas-Uélé) a été touchée au cours des dernières 24 heures. De ce fait, 58 des 151 zones de santé des six provinces sont désormais affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (13/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 24 août 2026)

Province	Total cas confirmés	Total décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4716	2 119	44,9%	28/36 (77,8 %)	61
Nord-Kivu	735	501	68,2%	13/34 (38,2 %)	7
Haut-Uélé	184	85	46,2%	6/13 (46,1 %)	3
Tshopo	15	8	53,3%	7/23 (30,4 %)	0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	3	1	33,3%	3/11(27,3%)	1
Total	5 656	2 715	48,0%	58/151 (38,4 %)	72

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 24 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4716	2119	44,9%	61	15	16	31
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	139	29	20,9%	12	1		1
Boga	2	2	100,0%	1	1		1
Bunia	1312	411	31,3%	14	6		6
Damas	27	9	33,3%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	73	30	41,1%				0
Gethy	5	2	40,0%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	61	39	63,9%	2	1		1
Lita	204	111	54,4%	7	2		2
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	18	4	22,2%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	14	7	50,0%				0
Mandima	32	19	59,4%				0
Mangala	203	109	53,7%	6	3		3
Mongbwalu	603	284	47,1%	1	1		1
Nia-Nia	193	108	56,0%				0
Nizi	622	252	40,5%	10	0		0

Nyankunde	123	35	28,5%	1	0		0
Rimba	10	4	40,0%				0
Rwampara	920	335	36,4%	7	0		0
Tchomia	55	25	45,5%				0
A ventiler*	NA	266	NA	NA	NA	16	16
Nord-Kivu	735	501	68,2%	7	3	0	3
Beni	118	84	71,2%	1	0	0	0
Butembo	140	107	76,4%	2	1	0	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	15	7	46,7%				0
Katwa	351	236	67,2%	3	2	0	2
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Masereka	7	4	57,1%				0
Musienene	70	41	58,6%				0
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	4	57,1%	1	0	0	0
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	184	85	46,2%	3	0	1	1
Boma Mangbetu	26	13	50,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	70	30	42,9%	2	0	1	1
Pawa	20	15	75,0%				0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	64	26	40,6%	1	0		0
Tshopo	15	8	53,3%	0	0	0	0
Bafwasende	1	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	6	4	66,7%				0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	1	33,3%	1	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	1	0	0,0%	1	0	0	0
Total	5656	2715	48,0%	72	18	17	35

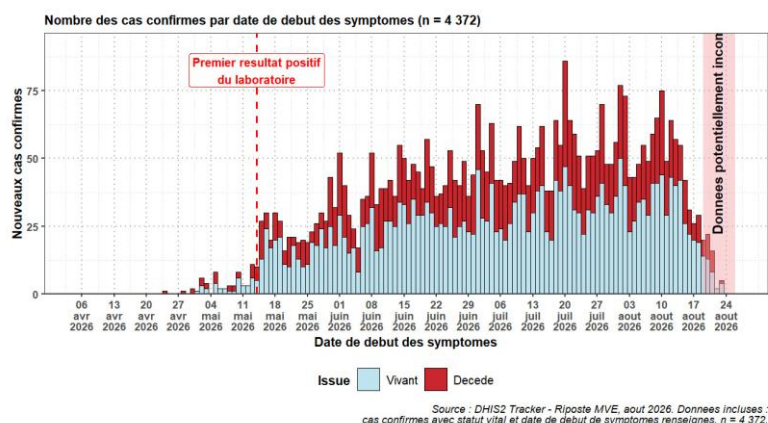
*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

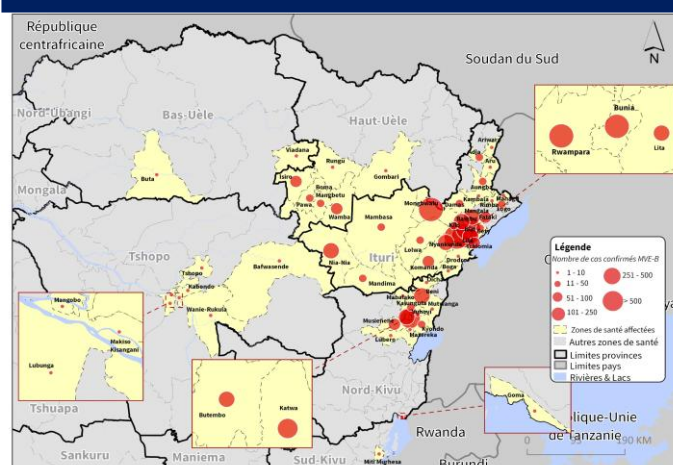
Situation des alertes notifiées par province, au 24 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	20	2	22	20	2	0	0	22	20
Bas Uélé	18	0	18	3	0	15	0	3	2
Ituri	614	50	664	103	38	423	4	141	87
Nord-Kivu	946	66	1012	79	58	836	0	137	63
Sud-Kivu	4	0	4	1	0	3	0	1	0
Tshopo	80	0	80	7	0	71	0	7	3
Total Général	1682	118	1 800	213	98	1348	4	311	175

Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



1. COORDINATION

1.1.Principales Actions

- **Nord-Kivu** : Superviser les travaux de l'élaboration des plans zonaux de correction et formation de 50 superviseurs de proximité de la réponse communautaire dans les neuf zones de santé touchées ;
- **Ituri** : Poursuite de la supervision des activités de la riposte et tenue de la réunion de la coordination ;
- **Tshopo** : Tenue de la réunion de la coordination et poursuite de la supervision des activités de la riposte ;
- **Sud-Kivu** : Poursuite de l'intensification de la surveillance et de la recherche active dans les ZS d'Ibanda et de Nyangezi ; la province totalise 74 jours sans nouveau cas confirmé et le dernier remonte au 10 juin 2026 ;

- **Bas-Uélé** : superviser les investigations autour du nouveau cas confirmé de l'aire de santé d'Agri-Uélé (ZS de Ganga).

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme de la journée du 24 août 2026, 1 800 alertes ont été enregistrées, dont 1 663 (92,4%) ont été vérifiées dans les six provinces affectées. À l'issue de ces vérifications, 311 (18,7%) ont été validées comme cas suspects et tous ont été investigués, parmi lesquels 175 ont été transférés vers les CT/CTE.

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 80,9 % (19 495 vus sur 24 106 à suivre), en dessous du seuil de 85 % : Ituri 87,2 % (11 865/13 611), Tshopo 100,0% (489/489) et Nord-Kivu 73,3 % (5 903/8 053). Le Haut-Uélé 64,3% (1 105/1 719) et Bas Uélé 56,8% (133/234) affichent des faibles taux de suivi.

2.1.2. Défis

Faible suivi des contacts autour des cas confirmés principalement dans les provinces du Haut Uélé et du Bas Uélé lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités et complétude insuffisante en Ituri (11 ZS n'ont pas transmis les données sur le suivi des contacts).

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

2.2.1. Principales actions

- Douze (12) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : cinq en Ituri, dont quatre alertes vivantes validées et transférées au CT/CTE (100 %) et un corps sans vie intercepté au PoC de Mangina (ZS Komanda) non swabé pour raisons sécuritaires ; trois au Nord-Kivu, une validée au PoC Foner Kasindi, et une au Bas-Uélé (PoC PK2 Titule), validée et investiguée dans les deux heures.

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,3 % (59/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	85 % (17/20)	54,5 % (6/11)	22,2 % (4/18)	80,1 % (109/136)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	NA	NA	NA	NA	ND	9,1 % (1/11)
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	150 290	90 879	10 657	2 925	9 080	793	264 624
% des voyageurs screenés	98,0 %	97,77 %	98,4 %	99,5 %	97,0 %	100 %	97,9 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,2 %	97,77 %	98,4 %	97,7 %	97,0 %	100 %	97,5 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	97,77 %	100 %	100 %	97,0 %	78,8 %	98,8 %
Nombre d'alertes notifiées	5	3	0	3	0	1	12
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	4	1	0	3	0	1	9
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	0	0	0	1
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (4/4)	100 % (1/1)	0 %	66,6 % (2/3)	0 %	0 % (0/1)	77,8 % (7/9)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	0 % (0/1)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % (0/1)

% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (5/5)	100 % (3/3)	0 %	100 % (3/3)	0 %	100 % (1/1)	100 % (12/12)
--	-------------	-------------	-----	-------------	-----	-------------	---------------

2.2.2. Défis

Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la complétude nationale n'atteint que 80,1 % (109 rapports sur 136), avec des niveaux faibles au Bas-Uélé (22,2 %) et au Haut-Uélé (54,5 %). En Ituri, 1 (9,1 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption ; au Haut-Uélé, cinq PoC (Dusu, Apodo, Aungba, PK6 Niangara et Gossamu) n'ont pas fonctionné à cause de la grève des prestataires non rémunérés ; la Tshopo et le Sud-Kivu n'ont pas transmis de données du jour.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 61 nouveaux résultats positifs** (46 vivants et 15 décès) sur 347 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 17,6 %**) ;
- **Nord-Kivu : 7 nouveaux résultats positifs** (4 vivants et 3 décès) sur 99 échantillons analysés (**positivité de 7,1 %**) ;
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs** (tous vivants) sur 18 échantillons analysés (**positivité de 16,7 %**) ;
- **Bas-Uélé : 1 nouveau résultat positif** sur 4 échantillons analysés (**positivité 25%**).

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 23 rings ont été ouverts sur les 59 identifiés (39,0 %), 76 ménages décontaminés sur 98 identifiés (77,5 %) et 7 FOSA sur 7 (100 %) ; 5 évaluations de FOSA ont été réalisées ;
- **Au Nord-Kivu**, 6 rings ont été ouverts à Beni, 17 FOSA et 5 ménages décontaminés ; 200 FOSA ont été suivies et accompagnées et 689 prestataires briefés. Le pilier EDS a reçu 44 alertes (15 reports) : 44 corps swabés sans échec et 44 EDS réalisés ;
- **Au Bas-Uélé**, 11 des 13 ESS ciblés ont été accompagnés et 11 ESS restent sous surveillance PCI ; 3 rings ont été ouverts (Buta, Viadana et Ganga) et l'HGR de Ganga a été évalué (score card de 32,8 %). Aucune alerte de décès n'a été reçue et aucun EDS n'a été réalisé ;
- **À la Tshopo**, 16 ESS ont été accompagnés dans 3 zones de santé (Makiso-Kisangani, Mangobo et Kabondo), où 138 prestataires ont été briefés ; suivi de la fonctionnalité de 15 dispositifs de lavage des mains et 16 unités de triage installées. La formation de 35 hygiénistes (5 équipes) de 4 zones de santé a démarré et un EDS a été réalisé à la morgue de l'HGR Makiso.

2.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings reste limitée à 39,0 % et 2 échecs de swab ont été enregistrés ; un membre de l'équipe EDS est décédé dans un accident de circulation (ZS Bambu) et deux autres ont été agressés à Rwampara (AS Makabo) ;
- Au Bas-Uélé, la décontamination du ménage des proches du premier cas confirmé de Buta n'a toujours pas pu être réalisée en raison d'une résistance communautaire persistante, le pré-rupture de plusieurs intrants PCI retardant le briefing des 500 prestataires des ZS d'Aketi, Likati, Bondo, Monga et Bili ;

- Au Nord-Kivu, des résistances aux enterrements dignes et sécurisés persistent à Katwa, Butembo, Kalunguta et Beni, et la route du cimetière de Bundji (ZS Beni) demeure impraticable.

2.5. Continuité des soins

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 76 nouvelles admissions ont été enregistrées et 109 sorties dont 23 guéris. Ainsi, 522 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation global de 53,4 % ;
- **Au Nord-Kivu**, 32 admissions ont été enregistrées pour 35 sorties dont 4 guéris. Au terme de la journée, 178 patients sont hospitalisés pour 206 lits, soit un taux d'occupation global de 86,4 % ;
- **À la Tshopo**, 4 nouvelles admissions de cas suspects et 10 patients isolés pour 14 lits, soit 71,4 % d'occupation ;
- **Au Bas Uélé**, 1 cas confirmé est en isolement à l'HGR Ganga ;
- **Au Haut Uélé**, 12 admissions ont été enregistrées pour 3 sorties, dont 3 guéris. Un total de 81 patients sont en isolement pour 130 lits, soit 62,3 %.

2.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence des CTE dans certaines zones de santé ; saturation des CTE de Bambu (confirmés), Kilo et Kigonze (suspects) en Ituri et dépassement de la capacité en lits suspects au Nord-Kivu (143 patients pour 142 lits).

2.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 246 contacts ont été listés autour des cas confirmés (85 à Rwampara, 124 à Lolwa et 37 à Kilo) ; 9 EDS ont été facilités, 13 familles conscientisées et 7 résultats positifs annoncés aux familles. Au total, 10 303 personnes ont été touchées par les activités de communication (5 645 lors de visites à domicile, 3 175 en causeries éducatives, 1 423 en sensibilisation de masse et 60 en plaidoyer et dialogue communautaire) ; 22 émissions et 6 spots radio ont été produits, 36 radios communautaires engagées et 42 supports IEC diffusés ;
- **À la Tshopo**, 1 272 personnes ont été sensibilisées lors de visites à domicile dans 212 ménages de Makiso, Mangobo et Kabondo ; des spots ont été diffusés sur 6 chaînes de radio et de télévision, les cadres et agents de la Direction provinciale de l'Éducation ont été sensibilisés et une rumeur a été clarifiée ;
- **Au Nord-Kivu**, 8 cas ont été couverts et 42 responsables de ménages touchés dans 8 zones de santé ; 17 rumeurs ont été clarifiées, 300 leaders de jeunes sensibilisés à Butembo et 3 guéris du CTE de Katwa ont témoigné devant la communauté ;
- **Au Haut-Uélé**, 2 853 personnes ont été touchées par les activités de communication : 1 517 lors de visites à domicile dans 312 ménages, 1 279 en causeries éducatives et 57 en sensibilisation de masse. Cinq radios locales ont diffusé les messages et 53 supports IEC ont été distribués, portant le cumul à 381 ;

- **Au Bas-Uélé**, une séance de sensibilisation à la MVE, aux mesures de prévention et à l'enterrement digne et sécurisé a été organisée auprès du groupe des jeunes de l'avenue Mobenge à Buta, assortie de la remise d'un dispositif de lavage des mains.

2.6.2. Défis

Persistance de défis communautaires : en Ituri, des refus de prélèvement (Nia-Nia), de swab (Alimasi) et de listage des contacts (Kilo État, 48 contacts) ont été enregistrés ; seules 8 des 28 zones de santé touchées de l'Ituri et 2 du Nord-Kivu ont remonté les préoccupations communautaires, soit 19 % des zones affectées du pays (contre 23 % la période précédente). Au Haut-Uélé, les équipes de riposte ont été agressées à Isiro et à Pawa.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 24 nouveaux cas confirmés couverts et 108 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 24 nouveaux suspects et 120 suspects en cours de suivi ; 76 ménages ont été accompagnés, 47 PPL soutenus, 39 enfants suivis en communauté et 55 annonces de résultats réalisées, dont 24 positives. Vingt guéris sur 23 (87 %) ont été réinsérés ;
- **Au Nord-Kivu**, la totalité des nouveaux cas confirmés et 65 des 94 nouveaux cas suspects (65,6 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 87 annonces de résultats sur 134 attendues (64,9 %) ont été réalisées, 93 PPL et 72 ménages affectés accompagnés et 13 enfants séparés ou orphelins suivis en communauté ;
- **Au Haut-Uélé**, 1 nouveau cas confirmé et 27 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'un appui psycho-social, ainsi qu'un nouveau suspect, 32 accompagnants et 29 PPL ; 11 annonces de résultats ont été faites, dont 3 positives. La couverture reste limitée à 2 des 6 zones de santé affectées (33 %), faute d'agents psychosociaux en nombre suffisant ;
- **À la Tshopo**, 2 nouveaux cas suspects et 2 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'un entretien et d'un soutien psychologique, ainsi que 17 accompagnants de cas hospitalisés ; 3 résultats de laboratoire ont été annoncés, dont aucun positif, et 406 personnes touchées par la psychoéducation en milieu religieux.

2.7. Logistique

2.7.1. Principales actions

- Au Nord-Kivu, réception de 13 tonnes d'intrants PCI/WASH livrés par l'UNICEF à Butembo et Katwa et de six véhicules 4x4 pour les zones de santé de Butembo, Katwa et Beni ; poursuite des travaux de construction du CT de Matanda.

2.8. Sécurité

2.8.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, le pilier a assuré deux accompagnements des équipes PCI (CS Dokotolo/AS Butsili et CS Ngalika/AS Ruwenzori) et un accompagnement des équipes EDS au cimetière de Bundji (100 % de réalisation). La sécurisation permanente de toutes les morgues de la ville de Beni a été décidée après le caillassage de la morgue de Ngalika et l'enlèvement d'un corps par la population.

- **2.8.2. En Ituri**, la sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : un corps sans vie intercepté au PoC de Mangina (ZS Komanda) n'a pu être swabé pour raisons d'insécurité.

2.8.3. Défis

En Ituri les équipes de santé animale ne peuvent réaliser de prélèvements faute de formation, alors que 29 animaux morts ont été investigués et 4 nouveaux cas d'hématurie bovine notifiés à Berunda. Au Sud-Kivu et au Haut-Uélé, la démotivation des acteurs liée au non-paiement persiste et a entraîné l'arrêt de cinq PoC au Haut-Uélé.

2.9. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

2.9.1. Principales actions

Poursuite d'appui à une formation des leaders communautaires, militaires et policiers sur la PSEA et la MVE, conjointement avec le pilier communication.

2.9.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA, limitée à 4 zones de santé sur 36 en Ituri, absence de cartographie des intervenants, insuffisance de supports de sensibilisation de masse et manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier. La couverture demeure limitée à 4 des 36 zones de santé de l'Ituri (11,1 %) et seuls deux partenaires (OMS et Africa CDC) rapportent leurs activités PSEA.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 72 nouveaux cas dont 18 décès communautaires et 17 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 5 656 cas confirmés et 2 715 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 83,4 % des cas confirmés cumulés et 84,7% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100,0%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (80,9%) en dessous du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard
Dr Katusi Biselenge Jules
Madame Mayele Afua Marie
Dr Diur Mananashi Floryan
Mr Kamuina Kebela John



Contact :
www.insp.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd